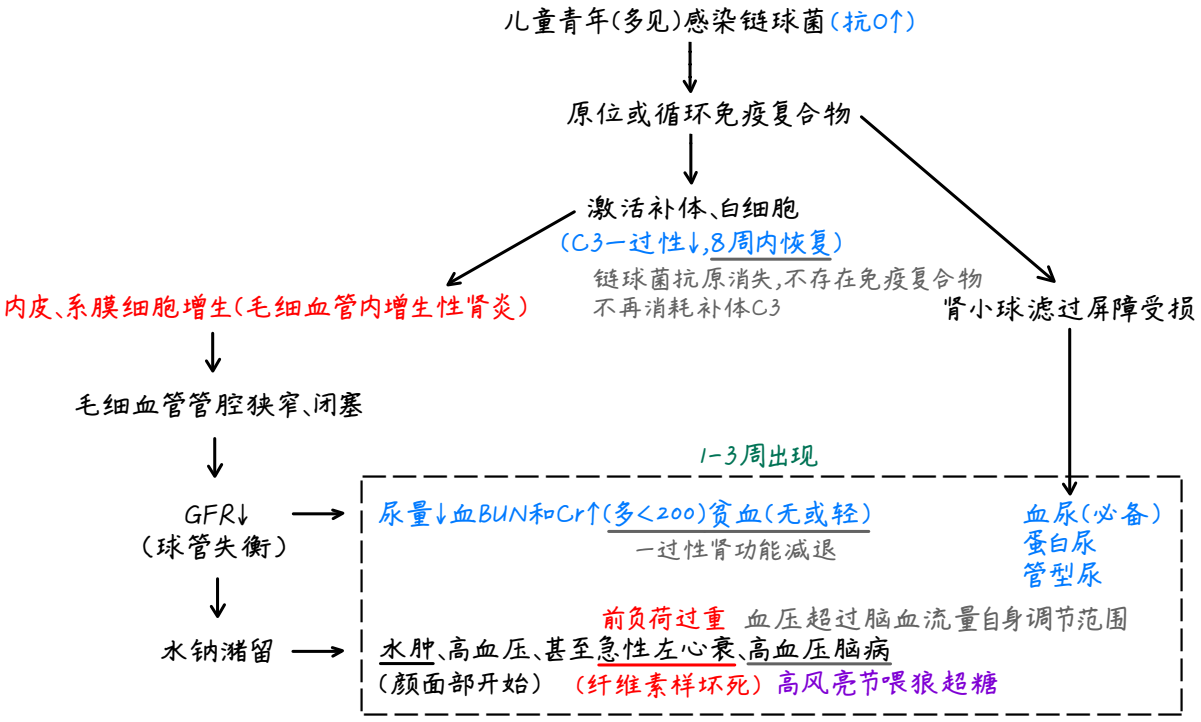
（三）临床表现



（四）急性肾炎的肾活检指征

①伴肾功能恶化：少尿 1 周以上、进行性尿量减少、血肌酐持续升高

②伴肾病综合征

③病程超过 **8** 周而无好转趋势 正常补体C3下降8周内恢复

急性肾炎出现高血压急症,首选硝普钠 （五）对症治疗为主（自限性疾病）预后好,少数发展为慢性肾小球肾炎

1.降血压：**先用利尿剂消肿降压**（容量依赖型高血压）、后用 ACEI/ARB 或 CCB→ACEI/ARB有禁忌症选

起效快 尿蛋白排泄↓肾小球滤过率↓保护肾脏 但①不能消除水肿②起效慢

2.急性肾炎发作时感染灶多数已控制：无现症感染无需用抗生素，否则用青霉素；反复发作的扁桃体炎可在病情稳定后切除

3.**不**用糖皮质激素+免疫抑制剂 自限性疾病

五、急进性肾炎

基底膜断裂更加明显(脂性肾病没有基底膜断裂)
血管内大量纤维蛋白渗出,刺激肾小囊壁层上皮细胞增生以及大量单核细胞渗出,堆出新月体,使囊内压骤然升高

相差显微镜见大量变形红细胞
但急进性肾炎可能出现形态正常的红细胞
因为基底膜断裂、滤过屏障受损更明显,无法挤压红C

（一）名字

①毛细血管**外**增生性肾炎、**新月体**性肾炎：肾小囊**壁**层上皮细胞增生形成新月体（闭月）

VS急性肾炎血Cr<200,贫血无或轻度

②**快速进行性肾炎**：最突出的表现是**早期肾功能急剧恶化（血 Cr＞200、贫血有甚至中度及以上）**

《诊断学》：血红蛋白轻度贫血＞90、中度 60-90、重度 30-59、极重度贫血＜30g/L（血分三六九等）

（二）类型

电镜不能区分出电子致密物(线性与膜混到一起)

I型：抗肾小球**基底膜 GBM 抗体**型（预后最差）：**原位**免疫复合物，**线状荧光**。继发者为**肺-出血肾炎 Goodpasture** 综合征（一线妓院大换血）

规律:颗粒状荧光